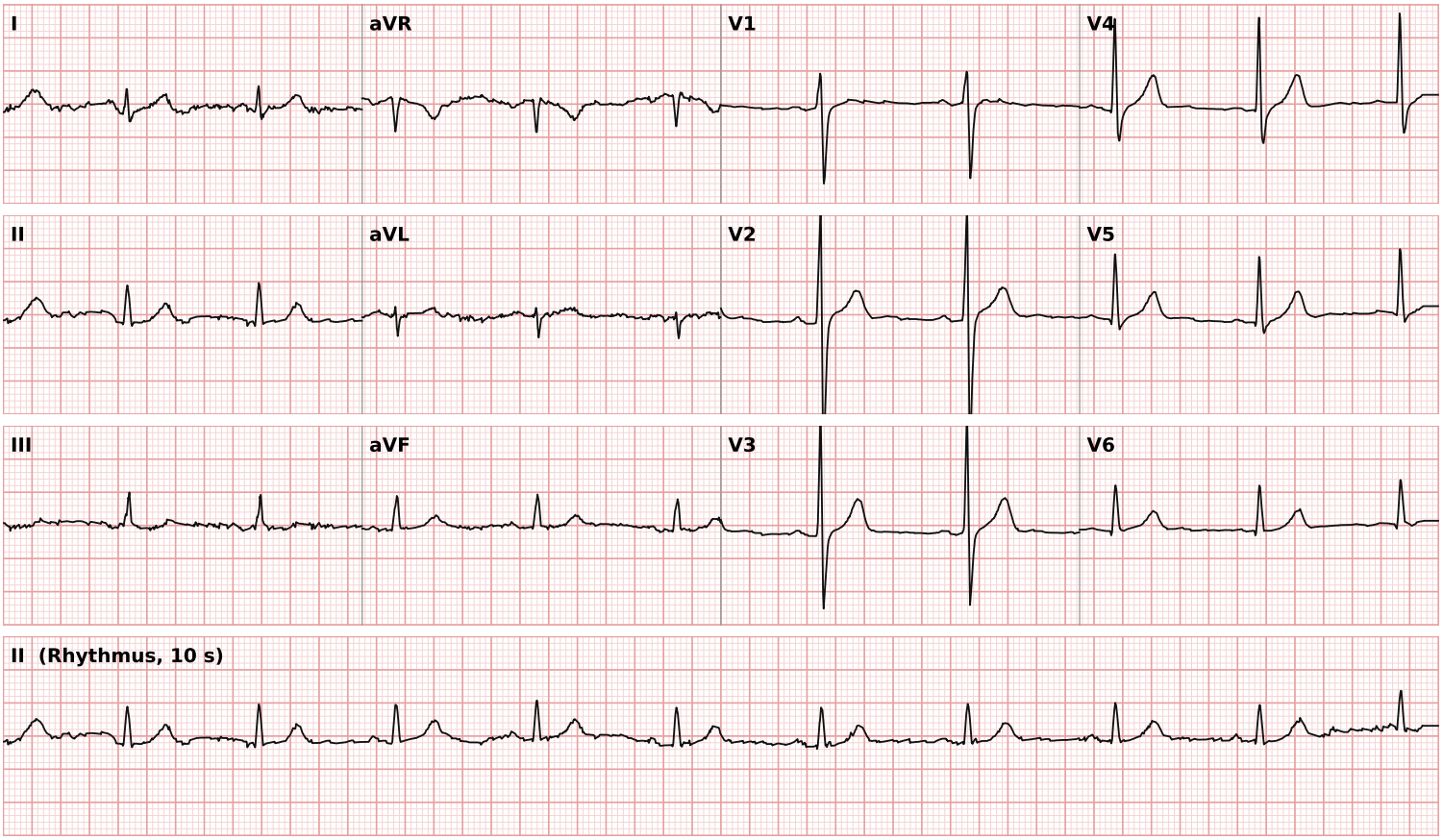
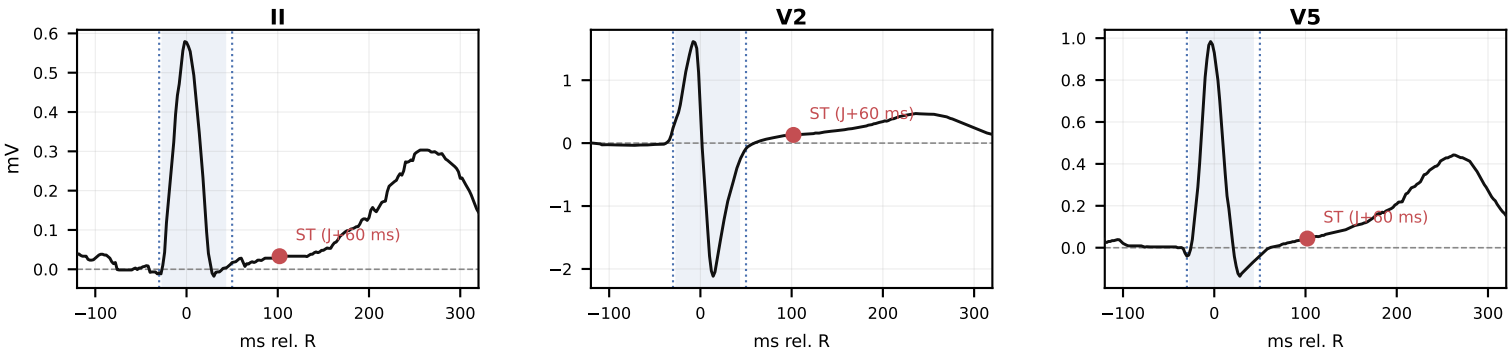
EKG 9 · männlich, 55 Jahre · Referenzdiagnose: NORM

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       61/min   RR-Median 984 ms   CV 0.033   Extrasystolen 0
  Zeiten         PQ 152 ms   QRS 104 ms   QT 378 ms   QTc 381 ms
  Herzachse      71.0°  →  Steiltyp
  Q-Zacken       keine pathologischen   Gruppen: –
  R/S (mV)       V1 0.48/1.12  V2 1.61/2.12  V3 1.73/1.10  V4 1.36/0.48  V5 0.98/0.14  V6 0.69/0.00
  R/S-Umschlag   V3   R-Progredienz regelrecht   S-Persistenz V6 nein
  ST (J+60 ms)   Hebung: –   Senkung: –
  T-Wellen       negativ in: aVR   davon pathologisch: –
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

Normokarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 61/min, Steiltyp. PQ-, QRS- sowie QTc-Zeiten normwertig. Kein Pardée-Q. Normale R-Progredienz, R/S-Umschlag in V3, keine S-Persistenz in V6. Keine relevanten ST-Hebungen oder -Senkungen. Keine T-Negativierungen. Keine Extrasystolen.

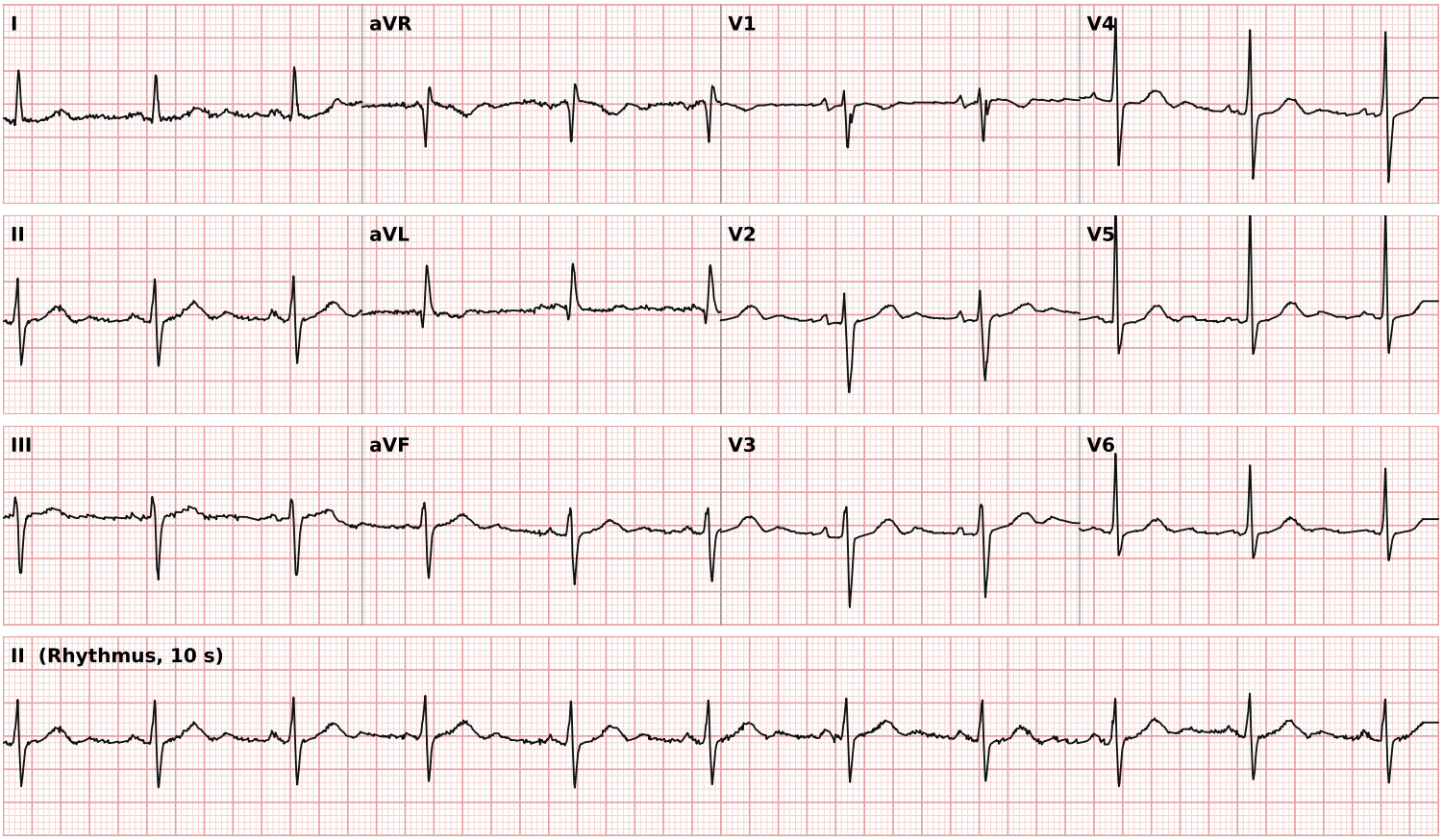
Beurteilung: Nachweis eines Normalbefundes.

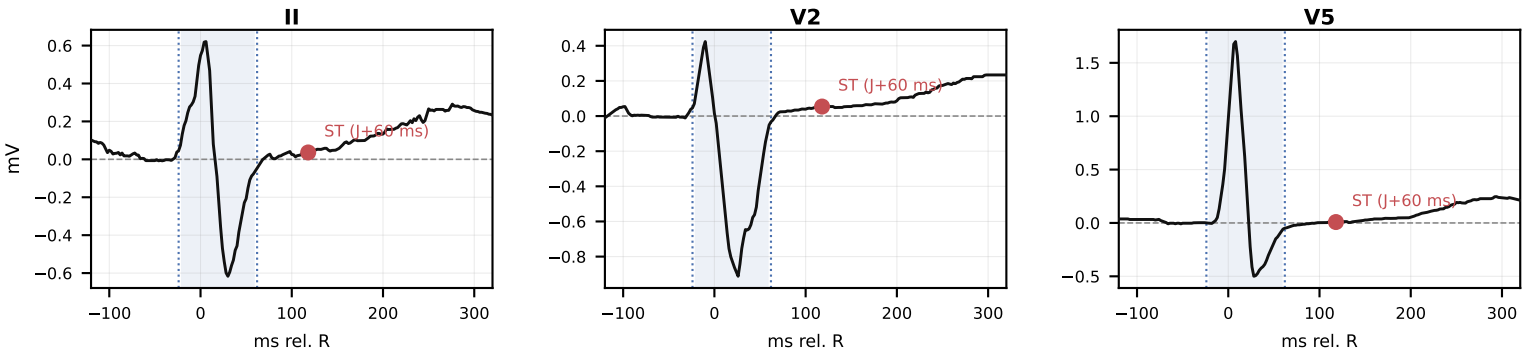
Einschränkung: Nebenbefundlich lag intraventrikuläre Leitungsverzögerung knapp über der Befundschwelle, jedoch deutlich unterhalb des Normalbefundes.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt. Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).

EKG 157 · weiblich, 74 Jahre · Referenzdiagnose: LAFB/LPFB

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       63/min   RR-Median 946 ms   CV 0.025   Extrasystolen 0
  Zeiten         PQ 139 ms   QRS 100 ms   QT 385 ms   QTc 394 ms
  Herzachse      -36.0°  →  überdrehter Linkstyp
  Q-Zacken       keine pathologischen   Gruppen: –
  R/S (mV)       V1 0.21/0.55  V2 0.42/0.91  V3 0.42/0.99  V4 1.21/0.96  V5 1.70/0.50  V6 1.07/0.38
  R/S-Umschlag   V4   R-Progredienz regelrecht   S-Persistenz V6 ja
  ST (J+60 ms)   Hebung: –   Senkung: –
  T-Wellen       negativ in: aVR   davon pathologisch: –
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

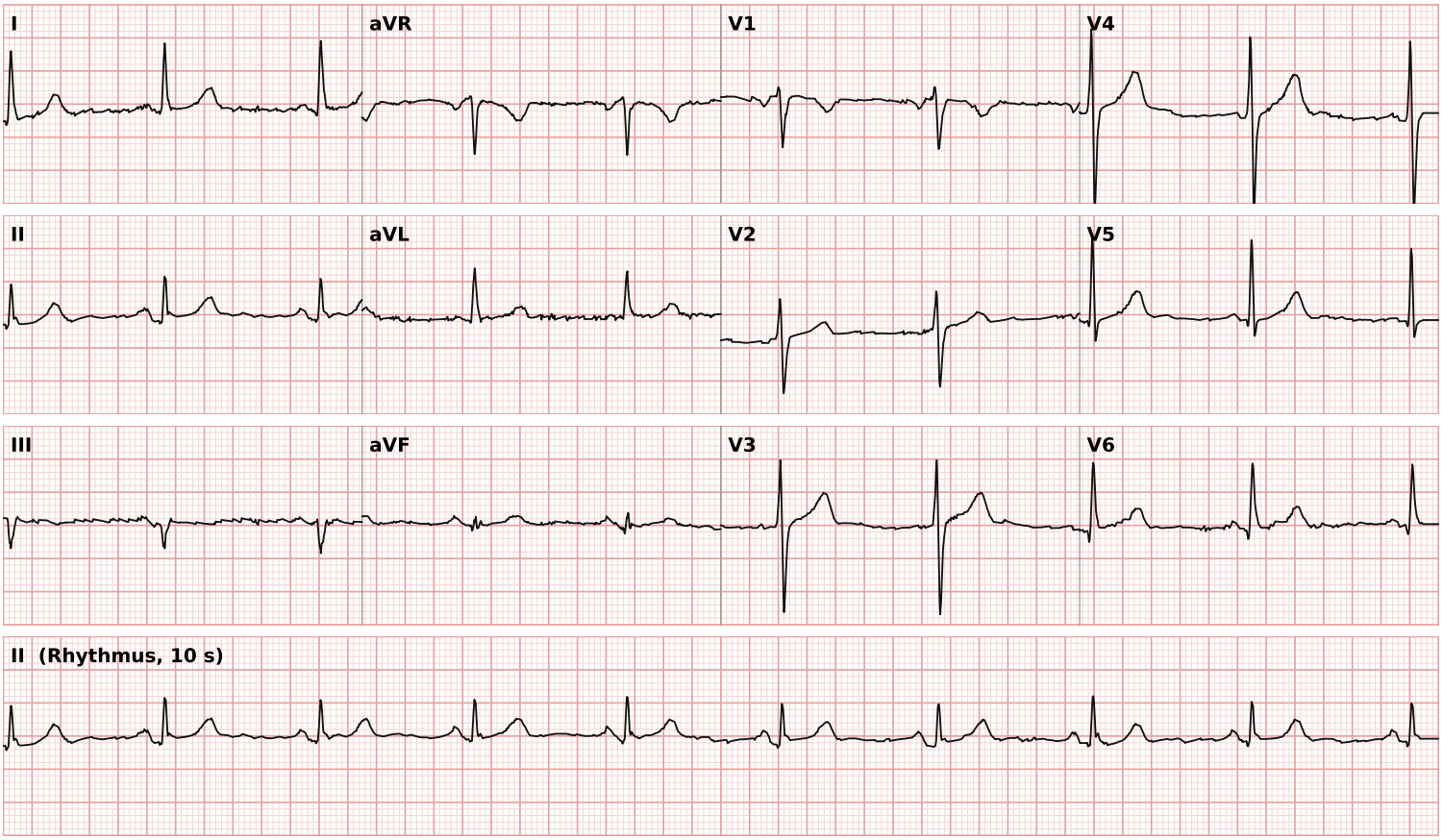
Normokarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 63/min, überdrehter Linkstyp. PQ-, QRS- sowie QTc-Zeiten normwertig. Kein Pardée-Q. Normale R-Progredienz, R/S-Umschlag in V4, S-Persistenz in V6. Keine relevanten ST-Hebungen oder -Senkungen. Keine T-Negativierungen. Keine Extrasystolen.

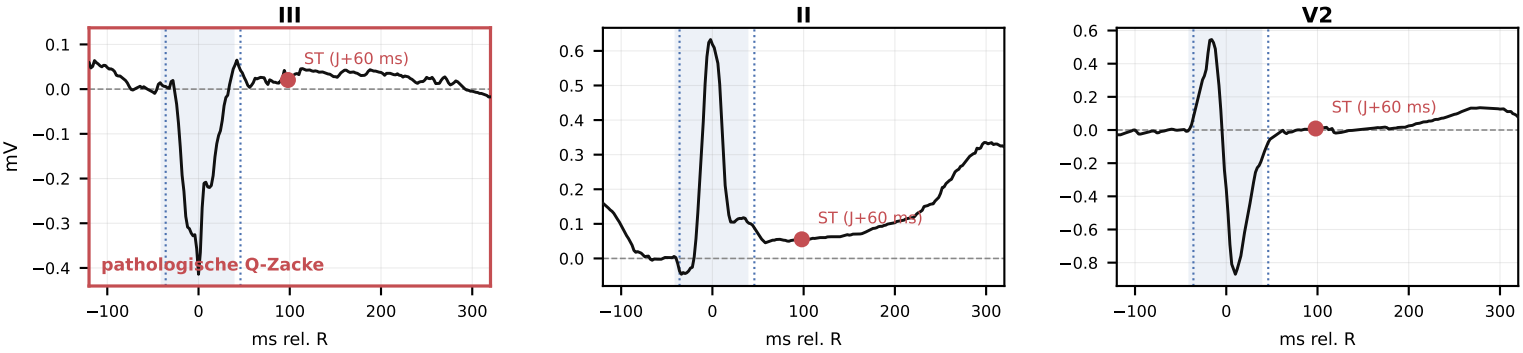
Beurteilung: Nachweis eines Hemiblocks. Vereinbar mit unspezifischen ST-T-Streckenveränderungen.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt.
Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).

EKG 175 · männlich, 64 Jahre · Referenzdiagnose: IMI

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       55/min   RR-Median 1083 ms   CV 0.015   Extrasystolen 0
  Zeiten         PQ 85 ms   QRS n. b.   QT 480 ms   QTc 460 ms
  QRS-Prüfung    verworfen: Messwege widersprechen sich: 148 ms gegen 82 ms (einmal schmal,
                 einmal verbreitert)
                 (Ableitung II 147.7 ms, 12 Ableitungen 82.0 ms)
  Herzachse      5.0°  → Linkstyp
  Q-Zacken       III   Gruppen: –
  R/S (mV)       V1 0.16/0.75  V2 0.55/0.87  V3 0.96/1.28  V4 1.22/1.45  V5 1.18/0.24  V6 0.95/0.00
  R/S-Umschlag   V5   R-Progredienz regelrecht   S-Persistenz V6 nein
  ST (J+60 ms)   Hebung: V4   Senkung: –
  T-Wellen       negativ in: aVR, V1   davon pathologisch: –
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

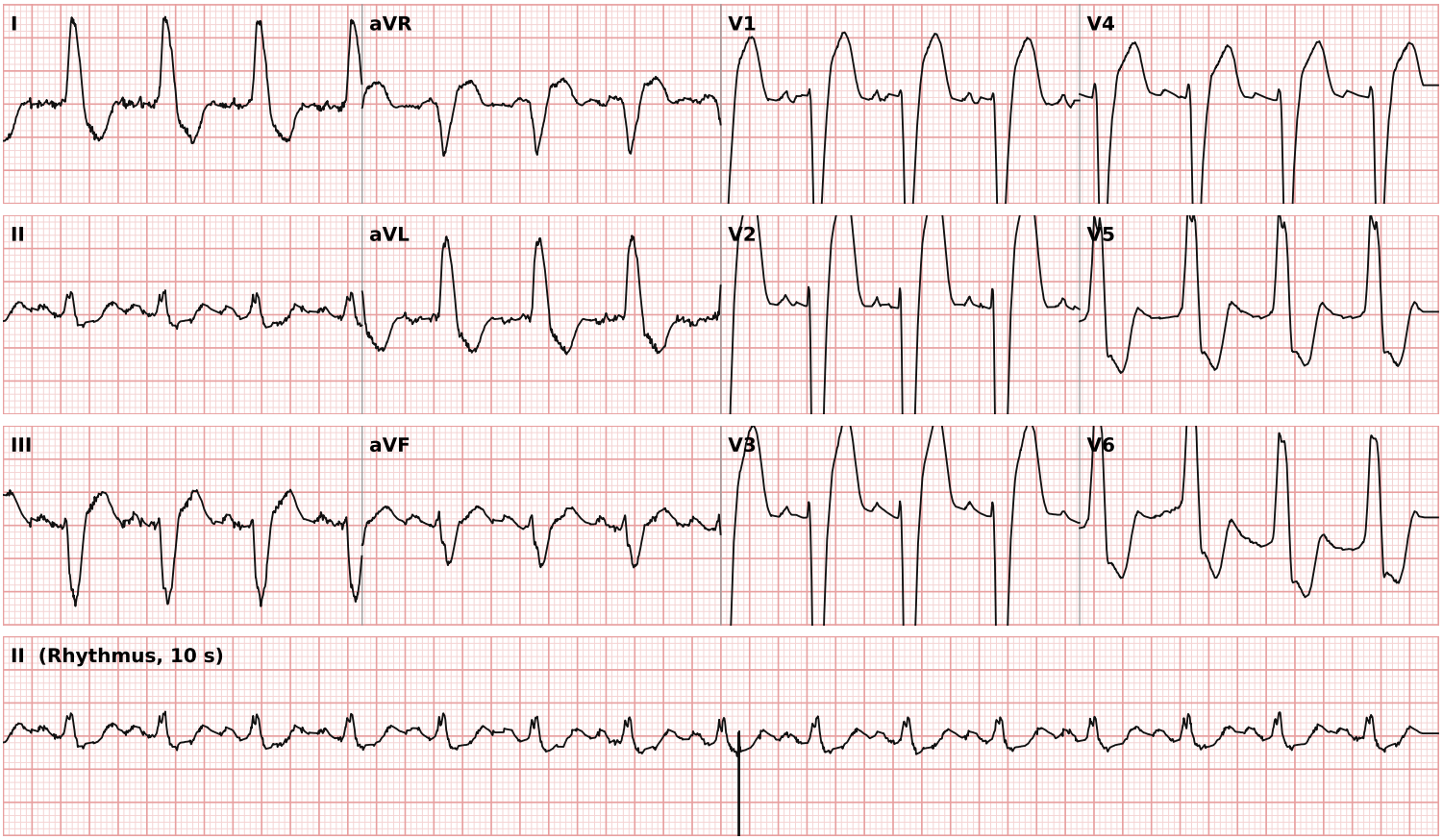
Bradykarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 55/min, Linkstyp. PQ-Zeit mit 85 ms verkürzt, QRS-Zeit nicht verwertbar, QTc-Zeit mit 460 ms verlängert. Kein Pardée-Q. Normale R-Progredienz, R/S-Umschlag in V5, keine S-Persistenz in V6. Keine relevanten ST-Hebungen oder -Senkungen. Keine T-Negativierungen. Keine Extrasystolen.

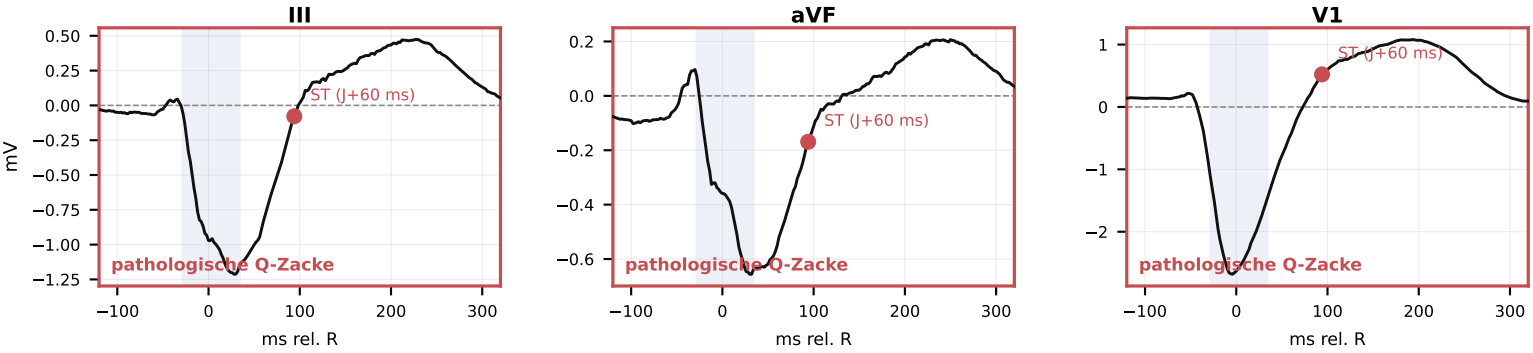
Beurteilung: Nachweis eines Hinterwandinfarktes.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt.
Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).

EKG 180 · weiblich, 81 Jahre · Referenzdiagnose: CLBBB

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       93/min   RR-Median 648 ms   CV 0.013   Extrasystolen 0
  Zeiten         PQ 190 ms   QRS n. b.   QT 348 ms   QTc 432 ms
  QRS-Prüfung    verworfen: zweiter Messweg (12-Ableitungs-Betrag) ohne Ergebnis — typisch
                 bei Schenkelblock, wo die Repolarisation nahtlos in den Kammerkomplex
                 übergeht
                 (Ableitung II 60.3 ms, 12 Ableitungen None ms)
  Herzachse      -21.0°  → Linkstyp
  Q-Zacken       III, aVF, V1, V2, V3   Gruppen: inferior, anteroseptal
  R/S (mV)       V1 QS  V2 QS  V3 QS  V4 0.15/1.85  V5 1.44/0.00  V6 1.53/0.00
  R/S-Umschlag   V5   R-Progredienz verzögert   S-Persistenz V6 nein
  ST (J+60 ms)   Hebung: aVR, V1, V2, V3   Senkung: I, II, aVF, V4, V5, V6
  T-Wellen       negativ in: I, aVL   davon pathologisch: I, aVL
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

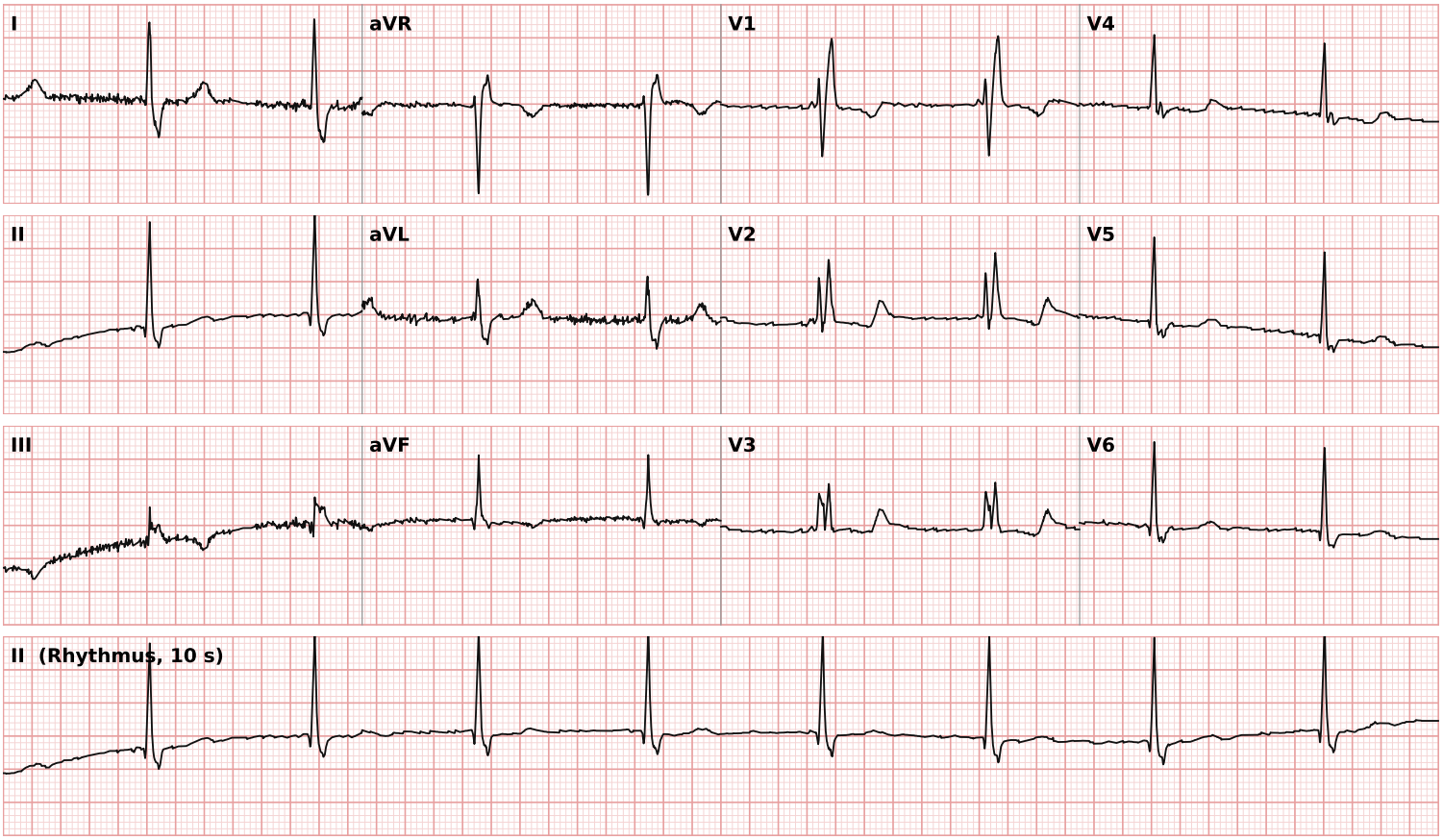
Normokarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 93/min, Linkstyp. QRS-Zeit nicht verwertbar, PQ-, QTc-Zeiten normwertig. Pathologische Q-Zacken in III, aVF, V1, V2, V3 (inferior und anteroseptal). Verzögerte R-Progredienz, R/S-Umschlag in V5, keine S-Persistenz in V6. ST-Hebungen in aVR, V1, V2, V3; ST-Senkungen in I, II, aVF, V4, V5, V6. T-Negativierungen in I, aVL. Keine Extrasystolen.

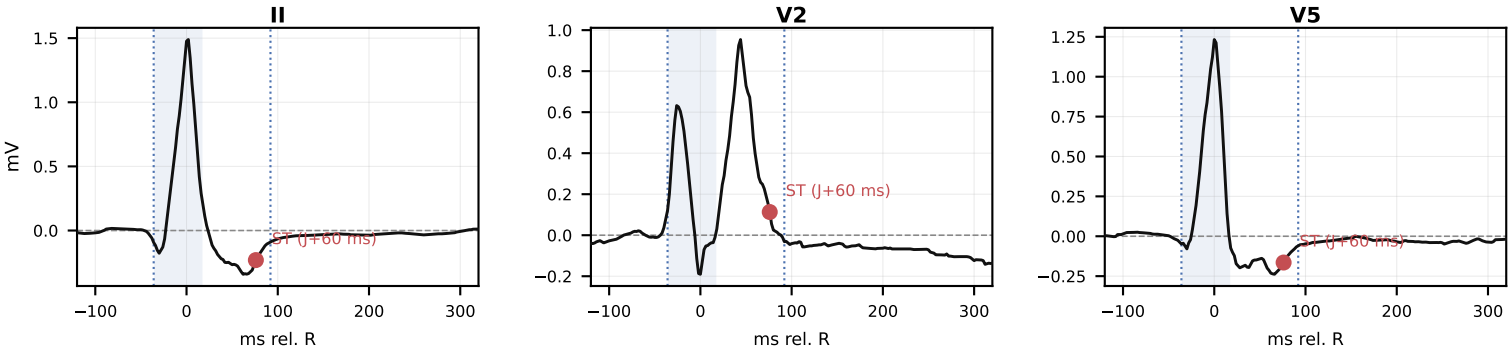
Beurteilung: Nachweis eines kompletten Linksschenkelblocks. Wahrscheinlich eine linksventrikuläre Hypertrophie.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt.
Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).

EKG 2433 · weiblich, 43 Jahre · Referenzdiagnose: CRBBB

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       51/min   RR-Median 1160 ms   CV 0.021   Extrasystolen 0
  Zeiten         PQ 210 ms   QRS 150 ms   QT 424 ms   QTc 392 ms
  Herzachse      29.0°  →  Linkstyp
  Q-Zacken       keine pathologischen   Gruppen: –
  R/S (mV)       V1 0.38/0.80  V2 0.63/0.19  V3 0.55/0.00  V4 1.07/0.00  V5 1.23/0.00  V6 1.23/0.00
  R/S-Umschlag   V2   R-Progredienz regelrecht   S-Persistenz V6 nein
  ST (J+60 ms)   Hebung: aVR, V1   Senkung: I, II, aVL, V4, V5, V6
  T-Wellen       negativ in: III, aVR, V1   davon pathologisch: –
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

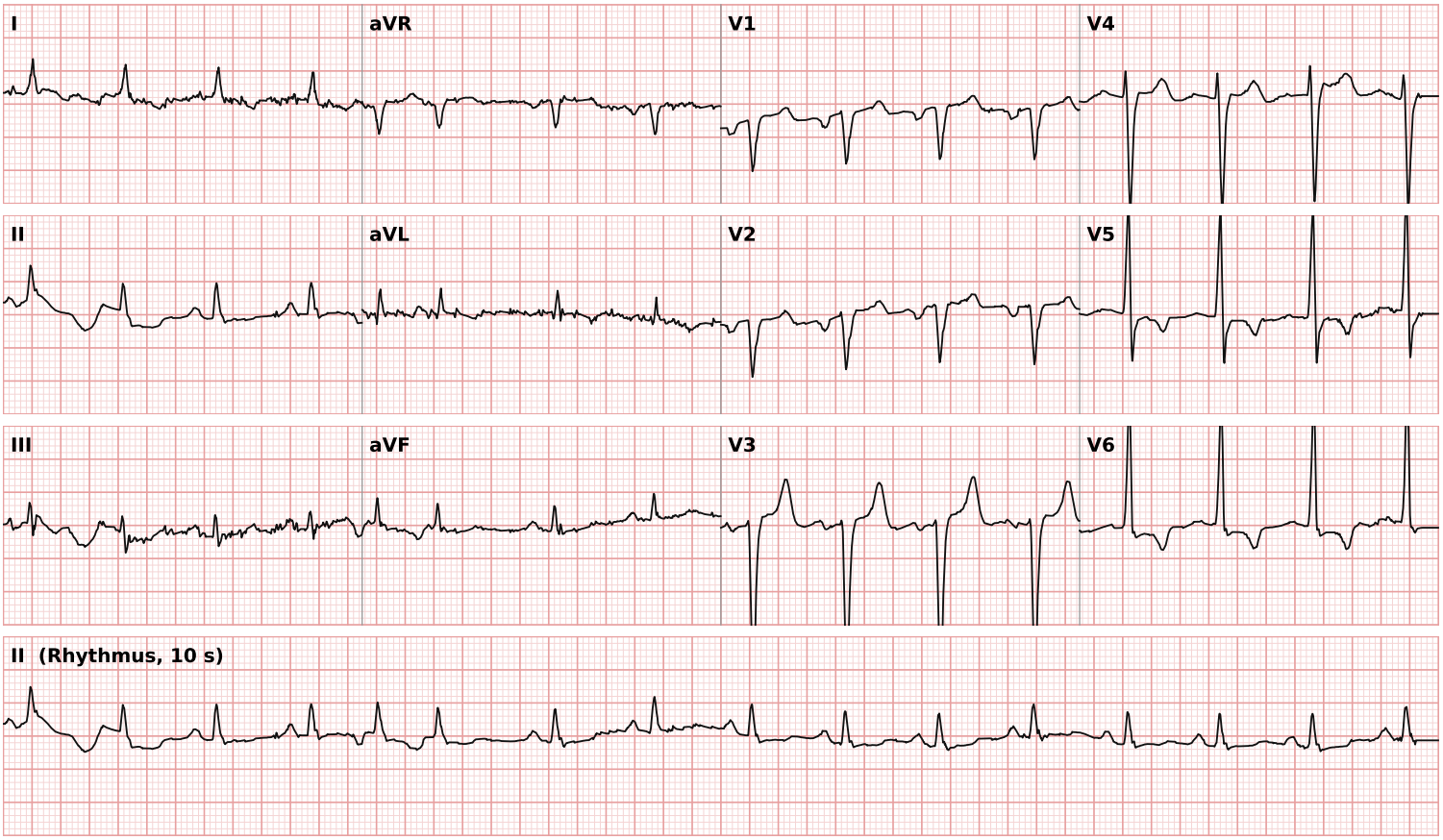
Bradykarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 51/min, Linkstyp. PQ-Zeit mit 210 ms verlängert, QRS-Zeit mit 150 ms verbreitert, QTc-Zeit normwertig. Kein Pardée-Q. Normale R-Progredienz, R/S-Umschlag in V2, keine S-Persistenz in V6. ST-Senkungen in I, II, aVL, V4, V5, V6. Keine T-Negativierungen. Keine Extrasystolen.

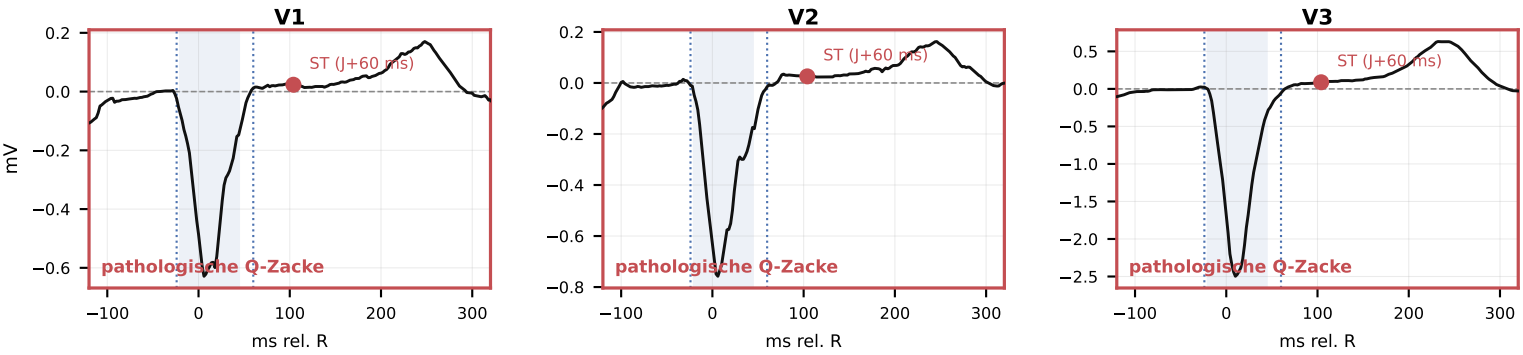
Beurteilung: Nachweis eines kompletten Rechtsschenkelblocks. Wahrscheinlich eine Hypertrophie oder Belastung.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt. Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).

EKG 271 · männlich, 75 Jahre · Referenzdiagnose: AMI, ISC_, LVH

12-Kanal-EKG, 25 mm/s · 10 mm/mV Median-Schlag mit Messpunkten unten






```
MESSGRÖSSEN (Feature Extraction)
  Frequenz       94/min   RR-Median 652 ms   CV 0.105   Extrasystolen 1
  Zeiten         PQ 118 ms   QRS 110 ms   QT 241 ms   QTc 301 ms
  Herzachse      30.0°  →  Linkstyp
  Q-Zacken       V1, V2, V3   Gruppen: anteroseptal
  R/S (mV)       V1 QS  V2 QS  V3 QS  V4 0.31/1.65  V5 1.62/0.69  V6 1.95/0.08
  R/S-Umschlag   V5   R-Progredienz verzögert   S-Persistenz V6 nein
  ST (J+60 ms)   Hebung: –   Senkung: V6
  T-Wellen       negativ in: V6   davon pathologisch: V6
```

BEFUND (regelbasiert aus dem Faktum-Set)

Normokarder Sinusrhythmus, durchschnittliche Frequenz 94/min, Linkstyp. PQ-Zeit mit 118 ms verkürzt, QTc-Zeit mit 301 ms verkürzt, QRS-Zeit normwertig. Pathologische Q-Zacken in V1, V2, V3 (anteroseptal). Verzögerte R-Progredienz, R/S-Umschlag in V5, keine S-Persistenz in V6. Keine relevanten ST-Hebungen oder -Senkungen. T-Negativierungen in V6. Eine Extrasystole, supraventrikulär (schmaler Kammerkomplex).

Beurteilung: Nachweis eines Vorderwandinfarktes. Nachweis einer Ischämie. Nachweis einer linksventrikulären Hypertrophie. Wahrscheinlich eine intraventrikuläre Leitungsverzögerung.

Blau: QRS-Fenster der Amplitudenmessung (gepunktet: weites Fenster für Q-Dauer und QRS-Dauer). Rot: ST-Messpunkt 60 ms nach dem J-Punkt.
Rot umrandet: Ableitung mit pathologischer Q-Zacke. Nulllinie gestrichelt (PQ-Segment).